

1. Introducción y relevancia clínica

El **pénfigo vulgar (PV)** es una **enfermedad ampollar autoinmune potencialmente mortal**, caracterizada por **ampollas flácidas intraepidérmicas** y **erosiones dolorosas** que afectan tanto la **piel como las mucosas**.

Es menos frecuente que el pénfigoide ampollar, pero clínicamente más severo debido a su tendencia a la **ruptura fácil de las ampollas**, generando grandes áreas denudadas, riesgo de **infección y sepsis**, y **mortalidad significativa** sin tratamiento adecuado.

Relevancia clínica

- Afecta principalmente a **adultos entre 40 y 60 años**, sin predilección por sexo.
 - Alta **morbilidad y mortalidad** si no se trata (hasta 80% en la era pre-corticoide).
 - **Diagnóstico temprano y tratamiento inmunosupresor** son determinantes del pronóstico.
 - En EUNACOM, es clásico el contraste con el **penfigoide ampollar**, enfatizando el **signo de Nikolsky positivo**, las **ampollas flácidas** y el **compromiso mucoso precoz**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo inmunológico

El pénfigo vulgar es una enfermedad autoinmune **mediada por anticuerpos IgG contra los desmosomas**, estructuras que mantienen la adhesión entre los queratinocitos.

- Los autoanticuerpos se dirigen principalmente contra:
 - **Desmogleína 3 (Dsg3)**: localizada en mucosas.
 - **Desmogleína 1 (Dsg1)**: localizada en piel.
- El tipo de desmogleína atacada determina la forma clínica:

- **PV mucoso:** anti-Dsg3.
- **PV mucocutáneo:** anti-Dsg3 + anti-Dsg1.

La unión de los anticuerpos produce:

- **Disrupción de los desmosomas** → pérdida de cohesión celular (**acantólisis**).
- Formación de **ampollas intraepidérmicas flácidas**.
- Activación del complemento y apoptosis de queratinocitos.

2.2. Factores predisponentes

- **Genéticos:** HLA-DR4, DR14, DQ5 (frecuente en judíos ashkenazíes, indios, mediterráneos).
- **Ambientales:** exposición a pesticidas, radiación UV, infecciones virales.
- **Fármacos:** penicilamina, IECAs (captopril), AINEs, rifampicina.
- **Factores psicológicos:** estrés severo puede desencadenar brotes.

2.3. Clasificación clínica

Subtipo	Autoanticuerpo principal	Sitio predominante
Pénfigo vulgar clásico	Anti-Dsg3 ± anti-Dsg1	Mucosas y piel
Pénfigo vegetante	Anti-Dsg3	Placas verrugosas en pliegues
Pénfigo foliáceo	Anti-Dsg1	Piel superficial, sin mucosas

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesión elemental

- **Ampolla flácida, de paredes finas**, fácilmente rompible.
 - Contiene líquido claro o turbio.
 - Al romperse deja **erosiones extensas, dolorosas y exudativas**.
-

3.2. Manifestaciones clínicas

a. Fase mucosa inicial

- En el 60–90% de los casos, **la mucosa oral es la primera afectada**.
- Erosiones dolorosas en mucosa bucal, paladar, lengua o encías.
- Dificultan la alimentación, provocan halitosis y pérdida de peso.

b. Fase cutánea

- Ampollas flácidas o erosiones en cuero cabelludo, cara, tronco y zonas intertriginosas.
- Lesiones nuevas aparecen en sitios de trauma (fenómeno de **Nikolsky positivo**).
- Lesiones tienden a confluir, generando áreas cruentas.
- Prurito leve o ausente; predomina el dolor.

c. Otras localizaciones

- Genitales, conjuntivas, nasofaringe, esófago, laringe (disfagia, odinofagia).
-

3.3. Signos característicos

- **Signo de Nikolsky positivo**: al frotar la piel perilesional se produce desprendimiento epidérmico.

- **Signo de Asboe-Hansen positivo:** presión sobre una ampolla intacta la extiende periféricamente.
- **Ausencia de prurito intenso** (a diferencia del penfigoide).
- **Erosiones mucosas crónicas** persistentes y dolorosas.

3.4. Diagnóstico diferencial

Enfermedad	Diferencias clave
Penfigoide ampollar	Ampollas tensas, Nikolsky negativo, prurito intenso, ancianos
Dermatitis herpetiforme	Ampollas pequeñas agrupadas, pruriginosas, codos y nalgas
SSJ/NET	Necrosis epidérmica aguda, fiebre, compromiso sistémico
Eritema multiforme	Lesiones en diana, curso autolimitado
Candidiasis oral / Aftas	Lesiones pequeñas, sin ampollas previas

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

- Sospechar en **adulto de mediana edad con erosiones orales dolorosas y ampollas flácidas cutáneas.**
- Nikolsky positivo.

4.2. Diagnóstico confirmatorio

Examen	Hallazgo característico
Biopsia de piel perilesional (H&E)	Ampolla intraepidérmica suprabasal con acantósis y células “en red”
Inmunofluorescencia directa (IFD)	Depósito intercelular de IgG y C3 en “panal de abejas”
Inmunofluorescencia indirecta (IFI)	Anticuerpos anti-desmogleína circulantes en suero
ELISA anti-desmogleína 1 y 3	Diagnóstico y seguimiento (niveles correlacionan con actividad)
Laboratorio general	Hemograma, función renal y hepática antes de inmunosupresión

4.3. Criterios diagnósticos de pénfigo vulgar

1. Ampollas flácidas o erosiones cutáneo-mucosas.
2. Signo de Nikolsky positivo.
3. Histología: ampolla intraepidérmica suprabasal con acantósis.
4. Inmunofluorescencia directa: IgG/C3 intercelular.
5. ELISA positivo anti-Dsg3 o anti-Dsg1.

Diagnóstico confirmado: ≥3 criterios presentes.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Principios terapéuticos

- Iniciar tratamiento precoz para detener la formación de nuevas ampollas.
- Promover la cicatrización de erosiones.
- Prevenir infecciones y efectos adversos por inmunosupresión.
- Mantener control clínico e inmunológico.

5.2. Tratamiento farmacológico

A. Corticoides sistémicos (pilar del tratamiento)

- **Prednisona:** 1 mg/kg/día (máx. 80 mg/día).
- En casos graves: **metilprednisolona IV pulsos (1 g/día × 3 días)**.
- Reducir gradualmente según respuesta (en 6–8 semanas).
- Mantención: 10–20 mg/día durante 6–12 meses.

B. Inmunomoduladores ahorradores de corticoides

Para reducir dosis de esteroides y prevenir recaídas:

Fármaco	Dosis habitual	Observaciones
Azatioprina	1–2 mg/kg/día	Monitorear hepatotoxicidad y leucopenia
Micofenolato mofetilo	1–2 g/día	Eficaz, bien tolerado
Metotrexato	7,5–25 mg/semana	Alternativa útil
Ciclofosfamida	1–2 mg/kg/día	Reservado para casos graves

Rituximab (anti-CD20)

Dosis IV cada 6 meses

Fármaco de elección en PV refractario o severo

MINSAL 2023: recomienda combinar corticoides + inmunomodulador desde el inicio en casos moderados a severos.

C. Terapias adyuvantes

- **Antibióticos tópicos o sistémicos** para infecciones secundarias.
 - **Antisépticos orales (clorhexidina 0,12%)** para erosiones bucales.
 - **Anestésicos tópicos (lidocaína viscosa)** para aliviar dolor.
 - **Suplemento de calcio y vitamina D** si uso prolongado de esteroides.
 - **Profilaxis antitrombótica y gástrica** durante terapia corticoidea.
-

5.3. Medidas no farmacológicas

- Evitar traumatismos, fricción y exposición solar.
 - Dieta blanda y fría si compromiso oral.
 - Higiene bucal y cutánea estricta.
 - Evaluación odontológica y oftalmológica en lesiones mucosas extensas.
-

5.4. Tratamiento de mantenimiento y seguimiento

- Mantener dosis mínima eficaz de corticoides o inmunomodulador.
- Control mensual durante el primer año.
- Monitorear anticuerpos anti-Dsg por ELISA para evaluar actividad y riesgo de recaída.
- Suspensión gradual de fármacos tras 12–18 meses sin lesiones.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Prevención / Manejo
Infecciones cutáneas o sistémicas	Piel denudada + inmunosupresión	Higiene, antibióticos dirigidos
Sepsis	Principal causa de muerte	Monitorización y antibióticos IV
Deshidratación / pérdida proteica	Por exudado de erosiones extensas	Hidratación, soporte nutricional
Efectos adversos de corticoides	Osteoporosis, diabetes, HTA	Profilaxis ósea, control metabólico
Recaídas	Comunes al suspender tratamiento precozmente	Retiro lento y control inmunológico

Pronóstico:

- Mortalidad actual <10% con tratamiento adecuado.
- 90% logra remisión completa en 1–3 años.
- Recaídas en 30–50%, pero responden a retratamiento.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Ampollas flácidas, Nikolsky positivo, compromiso mucoso precoz → pénfigo vulgar.**
 2. **Ampollas tensas, Nikolsky negativo → penfigoide ampollar.**
 3. **Biopsia suprabasal con acantólisis + IFD en panal de abejas** confirman el diagnóstico.
 4. **Corticoides sistémicos** son el tratamiento de elección.
 5. **Rituximab** ha revolucionado el manejo en casos refractarios.
 6. El **seguimiento con ELISA anti-desmogleína** predice recaídas.
 7. En EUNACOM, las preguntas destacan “erosiones orales dolorosas” como manifestación inicial.
-



Errores comunes

- Confundir con penfigoide (diferencias clínicas y anatomopatológicas).
 - No realizar biopsia o inmunofluorescencia.
 - Suspender corticoides bruscamente (riesgo de rebrote severo).
 - No iniciar inmunomodulador en casos moderados-graves.
 - Ignorar soporte nutricional e hidratación.
 - No vigilar infecciones en pacientes inmunodeprimidos.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **pénfigo vulgar** es una enfermedad autoinmune grave con **ampollas flácidas intraepidérmicas** y **erosiones mucosas**.
2. Causado por anticuerpos **anti-desmogleína 3 y 1**, que generan **acantólisis**.

3. El **signo de Nikolsky positivo** y el **compromiso mucoso precoz** son característicos.
4. El **diagnóstico** se confirma con **biopsia e inmunofluorescencia directa** en panel de abejas.
5. El **tratamiento de elección** son **corticoides sistémicos + inmunomoduladores**.
6. **Rituximab** es la terapia de elección en casos refractarios.
7. En EUNACOM, se evalúa principalmente el **reconocimiento clínico y terapéutico del pénfigo vulgar frente al penfigoide ampollar**.